Tumores benignos de la faringe

P Fayoux
D Chevalier
F Dubrulle

Resumen. – *Los tumores benignos de la faringe son afecciones raras cuyos orígenes son múltiples en razón de la diversidad de los elementos tisulares que constituyen ese conducto. Estas lesiones no suelen presentar características específicas ni en su sintomatología ni en su aspecto clínico. A menudo el diagnóstico etiológico se hace por radiología y por estudio histológico. Estas lesiones, aunque benignas desde el punto de vista histológico, pueden presentar un potencial evolutivo o de transformación maligna. El tratamiento debe tener en cuenta esta potencialidad.*

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

Los tumores benignos de la faringe son afecciones raras, que agrupan etiologías muy variadas, en razón de la multiplicidad de los elementos tisulares que la constituyen.

Por lo general, el aspecto clínico no es específico de un tipo lesional, por lo que para establecer el diagnóstico se recurre a menudo a la radiología y a la histología.

Algunas de estas lesiones son totalmente benignas mientras que otras presentan un potencial evolutivo o de transformación maligna, lo que explica que el tratamiento no sea siempre el mismo. Por este motivo, el diagnóstico y la terapéutica serán detallados para cada etiología.

Clínica

OBSERVACIONES QUE PERMITEN SU DIAGNÓSTICO

Los tumores benignos de la faringe no presentan características clínicas concretas. Sin embargo, la sintomatología que hace sospechar el diagnóstico tiene un carácter topográfico.

La obstrucción nasal uni o bilateral, de evolución progresiva, la rinolalia cerrada, la hipoacusia con autofonía, epistaxis generalmente moderadas pero repetidas y ronquidos o apnea del sueño orientan hacia una lesión rinofaríngea.

La disfagia, la odinofagia, la otalgia, parestesias faríngeas y disfonía orientan hacia una lesión oro o hipofaríngea. Cabe destacar que, en muchos casos, los tumores benignos de la faringe son un hallazgo fortuito durante una exploración clínica o radiológica.

Pierre Fayoux : *Interne des Hôpitaux, service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale.*
Dominique Chevalier : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale.*
Frédérique Dubrulle : *Praticien hospitalier, service de radiologie ouest.*
Centre hospitalier régional universitaire Claude-Huriez, avenue Oscar-Lambret, 59037 Lille cedex, France.

EXAMEN CLÍNICO

Debe abarcar el conjunto de la faringe. La exploración de la rinofaringe debe efectuarse con un nasofibroscopio o con una óptica rígida, tras la retracción mucosa con vasoconstrictores. Se busca la existencia o no de una lesión mucosa o submucosa, precisando el carácter macroscópico, las extensiones laterales o inferiores, el carácter hemorrágico y/o la existencia de una sobreinfección.

Se efectúa la exploración de la orofaringe y de la parte superior de la hipofaringe después de la exploración intraoral con un espejo laríngeo o con un nasofibroscopio. También aquí se busca la ausencia de una lesión mucosa o submucosa, una asimetría faríngea velar y/o lingual, la extensión a las estructuras adyacentes, la movilidad laríngea. La palpación cervical rigurosa servirá para detectar una masa profunda, valorando la movilidad, la consistencia y la sensibilidad.

La otoscopia deberá descartar una otitis serosa uni o bilateral.

EXÁMENES COMPLEMENTARIOS

■ *Diagnóstico radiológico*

El estudio radiológico permite orientar el diagnóstico etiológico gracias a cierta especificidad tisular de las imágenes y ayuda a tener idea de la extensión de la lesión.

Además, permite el diagnóstico diferencial con la extensión a la faringe, lesión adyacente, para el estudio de los espacios para y retrofaríngeos y del macizo facial.

El diagnóstico radiológico se basa en tres tipos de exploración: tomografía computadorizada (TC), resonancia magnética (RM) y angiografía vascular.

Tomografía computadorizada

En TC se suelen emplear dos planos de corte: el plano axial y el plano coronal. El plano sagital puede deducirse por reconstrucción a partir de los cortes axiales y coronales. En

las reconstrucciones la calidad de la imagen no es tan buena, pero permite aportar datos sobre la extensión de las lesiones.

Actualmente, la mayoría de las exploraciones se realizan por adquisición helicoidal en volumen. Esta forma de adquisición de las imágenes permite una duración de exploración corta de 30 a 50 segundos, lo que la hace más fácil de practicar en el niño. La adquisición de las imágenes se hace en cortes finos de unos 2 a 3 mm, lo que permite un análisis correcto de las relaciones entre el tumor y las estructuras adyacentes, pudiéndose obtener reconstrucciones en los diferentes planos del espacio, en particular el frontal y el sagital. Estos dos planos permiten un buen conocimiento de las extensiones, sobre todo en la base del cráneo.

La inyección de contraste informa sobre la vascularización de las lesiones.

Actualmente, para este tipo de tumor, suelen realizarse tres adquisiciones helicoidales: helicoidal sin inyección, helicoidal precoz y helicoidal tardía; también se efectúa una reconstrucción de constantes óseas.

Resonancia magnética

La RM permite obtener imágenes en todos los planos del espacio. Los planos de corte más utilizados para la faringe son los axiales y los frontales. La utilización de dos tiempos de relajación, potenciado T1 y potenciado T2, permite obtener imágenes de contrastes distintos.

La resolución espacial y la resolución con contraste son excelentes, permitiendo un estudio detallado de la extensión, sobre todo en los espacios profundos de la cara y de la base del cráneo.

La inyección de gadolinio permite estudiar la captación de contraste tumoral.

A pesar de tratarse de una exploración bastante prolongada, la RM permite un estudio tisular excelente y caracterizar algunos tejidos (imágenes de líquidos, grasa, etc.).

Evaluación vascular por imágenes

La angiografía sólo se realiza en caso de sospecha clínica y radiológica de malformación vascular.

La evaluación por angiografía digital se utiliza para el estudio de estas lesiones vasculares. Este examen pone de manifiesto las diversas aferencias de las lesiones y la extensión de las malformaciones vasculares. Sobre todo, sirve para realizar actos terapéuticos por embolización de dichas lesiones, en particular las malformaciones arteriovenosas y los hemangiomas.

■ *Biopsia*

Cuando los exámenes clínico y radiológico no permiten obtener el diagnóstico etiológico, debe considerarse el examen histológico por biopsia. Este examen es difícil de interpretar y tiene por objetivo principal, eliminar la sospecha de naturaleza maligna de la lesión.

Las biopsias pueden realizarse bajo anestesia local o general en el momento de una endoscopia, sobre todo en las lesiones hipofaríngeas.

Previamente habrá que descartar un meningoencefalocele o una lesión vascular. En caso de lesión abundantemente vascularizada, las biopsias deben realizarse en el bloque quirúrgico, con material de hemostasia adecuado.

■ *Particularidades en el recién nacido y en el lactante*

En el recién nacido y en el lactante, la sintomatología suele perder su carácter topográfico. Según la importancia del tumor, se puede observar un cuadro de insuficiencia respiratoria o de disnea más moderada, a veces acompañada de estridor, asociada a la aparición de dificultades de alimentación.

El tratamiento de estos niños precisa la restauración de una ventilación eficaz por intubación oro o nasotraqueal, mediante colocación de una cánula de Guedel, o por traqueotomía, según la localización tumoral.

El estudio clínico puede efectuarse con un nasofibroscopio o con endoscopio rígido, según el contexto, y explorar las fosas nasales, el conjunto de la faringe y la vía laringotraqueal. Si hace falta, la exploración clínica se completará con un escáner.

Etiologías

QUISTES

Quistes congénitos

El diagnóstico puede realizarse durante la infancia o en la edad adulta.

Quistes de la bolsa de Tornwaldt [28, 34, 50]

Estos quistes se desarrollan desde la bolsa faríngea, por encima del constrictor superior de la faringe, y toman el aspecto de una formación de retención, amarillenta, traslúcida, mediana, pudiendo llenar toda la rinofaringe. El escáner localiza una formación homogénea, no calcificada, que no capta contraste. A la RM aparece una hiperseñal en T2 homogénea, muy evocadora. El tratamiento es quirúrgico, mediante una marsupialización amplia.

Quistes de la bolsa de Rathke [34]

Estos quistes de origen ectodérmico y desarrollo medial son mucho menos frecuentes que los primeros. Se desarrollan de forma más anterior: a nivel de la bóveda del cavum, que corresponde al canal faringohipofisario; el aspecto clínico y radiológico es similar. El tratamiento es quirúrgico, por marsupialización amplia.

Quistes del conducto tirogloso y tiroides ectópico

Las anomalías de desarrollo de los esbozos embrionarios tiroideos pueden localizarse en la orofaringe. Su descubrimiento puede hacerse a cualquier edad.

— El quiste del conducto tirogloso resulta de un defecto de migración de los esbozos embrionarios. Este quiste, habitualmente cervical, puede localizarse en la base de la lengua. La complicación principal es la sobreinfección. El tratamiento es quirúrgico, por vía cervical (técnica de Sistrunck) [36, 15].

— Ectopia tiroidea: resulta de un defecto de migración del esbozo tiroideo, que puede quedar localizado en la base de la lengua.

La sintomatología orofaríngea puede asociarse a signos de hipotiroidismo.

A la exploración se encuentra una tumefacción medial que rechaza la mucosa basilingual, de aspecto violáceo. En general, la función tiroidea está disminuida, lo que permite el diagnóstico precoz por la dosificación sistemática de la TSH *(tiroid stimulating hormone)* en el recién nacido.

El tratamiento es médico, por hormonoterapia tiroidea sustitutiva.

Sólo precisan tratamiento quirúrgico las complicaciones disneicas, hemorrágicas o la transformación neoplásica [17, 21, 27, 49].

Quistes congénitos del segundo arco branquial [36, 43, 44]

Estos quistes laterales pueden tener una extensión endocavitaria predominante; su descubrimiento puede ser tardío. Se

sitúan en posición subhioidea, en la cara externa del eje yugulocarotídeo. Su expresión clínica suele ser cervical; se presenta como una tumefacción ovalada que tiene una cierta resistencia a la palpación. El diagnóstico se basa en el aspecto ecográfico hipoecógeno o por TC y se confirma por cervicotomía exploratoria y estudio histopatológico. El tratamiento es quirúrgico, por vía cervical, extirpando el quiste y el conjunto del trayecto fistuloso.

■ *Quiste de retención* [47]

Estas lesiones son secundarias a la obstrucción del conducto excretor o del ostium de las glándulas salivales accesorias y pueden aparecer en cualquiera parte de la faringe.

Si la lesión es sintomática, su tratamiento es quirúrgico, por exéresis o marsupialización amplia por vía endoscópica.

LESIONES VASCULARES

La clasificación de Mulliken [30] describe dos grupos de lesiones vasculares, los hemangiomas y las malformaciones vasculares propiamente dichas, que difieren por su evolución. Los primeros involucionan espontáneamente, mientras que las malformaciones vasculares permanecen estables o tienden a aumentar.

■ *Hemangiomas o angiomas inmaduros* [30]

Estos angiomas aparecen desde las primeras semanas de la vida, después siguen una fase proliferativa hasta los 8 o 12 meses antes de estabilizarse y luego reducirse. Así, a los 7 años, el 80 % de los angiomas fásicos ha desaparecido.

La localización faríngea es rara. Se asocia a una localización cutánea, endobucal o laringotraqueal. Las complicaciones pueden ser: disnea, hemorragia por ulceración o insuficiencia cardíaca, en caso de angioma extensivo importante. El tratamiento consiste en un simple seguimiento. En otros casos, según la extensión y la localización del angioma, el tratamiento puede incluir corticoterapia sistémica (2 a 3 mg/kg/d de prednisona), vaporización por láser o exéresis quirúrgica por vía externa.

■ *Malformaciones vasculares maduras* [7, 30]

Malformaciones capilarovenosas o venosas

Estas malformaciones están compuestas por una red vascular de tipo venoso o capilar que se distiende pasivamente en la presión sanguínea. Estas lesiones, que ya existen en el nacimiento, se desarrollan progresivamente, bajo la forma de una tumefacción azulada, fluctuante y depresible.

Para el diagnóstico de estas lesiones, la RM es la mejor exploración radiológica. Localiza una isoseñal en T1 y una hiperseñal en T2. La existencia de zonas calcificadas es un signo relativamente específico. El tratamiento se basa en la radiología operatoria por embolización de producto esclerosante acompañado de un tratamiento antiinflamatorio. Estas embolizaciones pueden repetirse, según la evolución. Si los resultados son insuficientes, puede asociarse un tratamiento quirúrgico sobre las masas venosas mucosas. A menudo, este método se asocia a la exéresis de las prolongaciones cervicofaciales y representa una cirugía difícil.

Malformación arteriovenosa (MAV)

Estas lesiones, constituidas por elementos vasculares arteriales y venosos, asociados por un sistema de shunt, presentan un potencial evolutivo responsable de complicaciones locales y generales por «secuestro» vascular. Las etapas evolutivas están frecuentemente ligadas a episodios de la vida hormonal o a factores traumáticos. Clínicamente, la MAV se presenta bajo la forma de una masa rojiza, pulsátil, a veces asociada a telangiectasias. Las complicaciones pueden ser locales (invasión de estructuras adyacentes, ulceración, necrosis o hemorragia a veces muy grave) o sistémicas (insuficiencia cardíaca por alto caudal). La exploración debe comprender una arteriografía digital selectiva, que confirma el diagnóstico y pone en evidencia las arterias nutricias y un escáner, o mejor una RM, que permite el estudio de extensión de la lesión. El control de estas malformaciones es esencial. Puede utilizarse la ecografía con doppler pulsado, que permite seguir las modificaciones del caudal arterial. El tratamiento de las MAV sólo se realiza en las lesiones que comprometen un pronóstico vital o funcional. Esencialmente se tratará con embolización por radiología operatoria, reservándose la cirugía para los fracasos de esta terapia.

Linfangiomas [1, 14, 16]

Los linfangiomas son malformaciones congénitas del sistema linfático, relacionados con los hamartomas. Estas lesiones blandas, fluctuantes, transiluminables, se desarrollan preferentemente en la orofaringe si son lesiones faríngeas, pero pueden encontrarse en todas las localizaciones cervicofaciales. Las complicaciones se deben a la compresión de la vía faringolaríngea o a infiltración mediastínica. Los aumentos de volumen, que pueden ser bruscos, pueden comprometer el pronóstico vital.

La exploración radiológica más eficaz sigue siendo la RM, que localiza una hiperseñal en T2 que reproduce los tabiques de la masa linfangiomatosa.

Debido a su riesgo evolutivo, el tratamiento de los linfangiomas debe ser precoz. Consiste en la exéresis quirúrgica lo más completa posible. A este método puede asociarse la inyección de esclerosante en los remanentes de las formas difusas. El pronóstico de los linfangiomas sigue siendo poco alentador, con una mortalidad postoperatoria de alrededor del 5 %, que puede llegar al 45 % en casos de extensión mediastínica.

■ *Quemodectomas o paragangliomas* [10, 26, 38]

Los tumores desarrollados a expensas de células del sistema APUD *(amine precursor uptake decarboxylation)* aparecen en la rinofaringe. Presentan un desarrollo branquiomérico submucoso en la región cervicofacial. El diagnóstico es radiológico, mediante RM y arteriografía de los ejes carotídeos. El estudio preterapéutico debe buscar:

— otra anomalía de las crestas neurales;

— otro tumor de tejidos derivados de las crestas neurales (tiroides, paratiroides, timo, páncreas, feocromocitoma, hipófisis);

— otro paraganglioma cervical o retroperitoneal.

TUMORES DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES ACCESORIAS [22, 29]

Estas lesiones submucosas pueden localizarse en todos los niveles faríngeos, pero predominan en la orofaringe. En principio son indoloras y no ulceradas; en estos tumores, el aumento de tamaño puede llevar a necrosis y sobreinfecciones.

La clasificación histológica agrupa estas lesiones en adenoma monomorfo común o específico y adenoma pleomorfo. Estos últimos son los más frecuentes y pueden presentar un riesgo de malignización a largo plazo.

El tratamiento de estos tumores es quirúrgico, por exéresis amplia para limitar las recidivas.

El estudio histológico de la pieza quirúrgica debe ser sistemático, para descartar un foco carcinomatoso.

QUISTES DERMOIDES, EPIDERMOIDES Y TERATOIDES [33, 35]

Los quistes epidermoides son quistes derivados de la epidermis encapsulada en una estructura fibrosa sin otra estructura anexial, lo que los diferencia de los quistes dermoides. Los quistes teratoides comprenden, además de los anexos, elementos derivados de las tres hojas embrionarias.

Las localizaciones son preferentemente orofaríngeas, mientras que las faríngeas son raras.

El aspecto clínico es el de una tumefacción submucosa no específica. En las formas estudiadas, el escáner orienta el diagnóstico y la extensión de la lesión.

El tratamiento es quirúrgico por enucleación de la lesión.

Las recidivas son escasas.

TERATOMAS [9, 13, 23, 40, 52]

Las lesiones formadas de derivados de las tres hojas embrionarias suelen asociarse a malformaciones craneales o a cardiopatías. Estas lesiones raras se desarrollan, preferentemente, en el niño y el adolescente. El riesgo de malignización carcinomatosa de los teratomas no es nulo, por lo que se impone la exéresis quirúrgica con estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica.

HAMARTOMAS [12, 37, 51]

Los hamartomas son proliferaciones celulares desarrolladas a expensas de los tejidos que conforman la faringe. Estas anomalías focales del desarrollo afectan frecuentemente al niño y al adolescente, predominantemente en la nasofaringe. El tratamiento es la exéresis quirúrgica.

TUMORES FIBROSOS

■ *Fibromas* [3, 47]

Los fibromas corresponden a una proliferación de tejido fibroso secundaria a una irritación crónica. Clínicamente, estas lesiones pediculadas o sésiles pueden llegar a alcanzar varios centímetros, afectan al adulto y predominan en la orofaringe.

El diagnóstico precisa una biopsia.

El tratamiento consiste en la exéresis quirúrgica de la lesión asociada a la eliminación del factor irritativo. Las recidivas son excepcionales.

■ *Fibromatosis extensa* [42]

La fibromatosis extensa (tumor dermoide) es un tumor invasivo desarrollado a expensas de los tejidos musculoaponeuróticos. Se trata de un tumor duro, indoloro, que afecta preferentemente al adolescente, pero que puede aparecer a cualquier edad. La localización faríngea más frecuente es en la base de la lengua. El diagnóstico histológico es difícil y debe efectuarse a partir de biopsias grandes y confirmadas sobre la pieza de exéresis. El estudio anatomopatológico revela una proliferación fibrostásica en un estroma fibroso, no encapsulado. La extensión tumoral se controla mediante RM, cuya hiposeñal en T2 no constante puede orientar el diagnóstico.

Se buscan además otras localizaciones. La evolución expansiva de esta lesión comporta el riesgo de complicaciones por compresión de la vía laringotraqueal y de las estructuras vasculonerviosas. El tratamiento de elección es la exéresis quirúrgica amplia.

Las recidivas son frecuentes, de aparición más corriente y rápida en el niño.

■ *Granulomas piógenos* [47]

Estas lesiones mucosas son secundarias a un traumatismo, a veces yatrógeno, o por un cuerpo extraño en el niño (cavum). Se trata de una lesión exofítica, inflamatoria, más o menos friable. El diagnóstico depende del contexto.

Inicialmente, el tratamiento tiene por objetivo eliminar todo factor traumático. La exéresis quirúrgica no se considera más que en caso de granuloma sintomático.

TUMORES DESARROLLADOS A EXPENSAS DEL SISTEMA NERVIOSO

■ *Schwannomas* [26, 39, 46]

Son tumores desarrollados a expensas de células de Schwann.

Estos tumores, cuya localización faríngea es inusual, pueden presentarse a cualquier edad, sin preponderancia de sexo. Los schwannomas de localización submucosa, sin carácter clínico específico, se desarrollan lentamente. Histológicamente, el schwannoma consta de dos tipos de células A y B de Antoni, que se desarrollan en una estructura encapsulada.

Neurofibromas [2, 26, 27, 39]

Los neurofibromas también se desarrollan a expensas de las vainas nerviosas.

Los neurofibromas son lesiones asintomáticas, a menudo múltiples, cuya forma clínica más frecuente es la enfermedad de von Recklinghausen. La lesión faríngea más habitual es basilingual, adoptando un aspecto de macroglosia unilateral. Pueden inscribirse en un síndrome neuroendocrino que asocia neurofibromas mucosos, feocromocitoma y carcinoma medular de tiroides. Los neurofibromas mucosos aparecen en la infancia y son a menudo las primeras manifestaciones de síndromes neuroendocrinos.

Histológicamente, el aspecto es parecido al del schwannoma, pero no hay cápsula.

Existe un riesgo de malignización entre el 5 y el 15 %, lo que justifica su tratamiento quirúrgico. En las localizaciones múltiples, sólo se operan los neurofibromas sospechosos de malignización.

■ *Neuromas traumáticos* [26, 47]

Los neuromas son reacciones hiperplásicas desarrollados a expensas de las fibras nerviosas y de las células de Schwann, a causa de un traumatismo. La localización faríngea es excepcional y afecta esencialmente a la base de la lengua. Clínicamente, los neuromas tienen el aspecto de un nódulo submucoso, sin carácter específico. El tratamiento consiste en su exéresis quirúrgica, con coagulación de las extremidades nerviosas para disminuir el riesgo de recidiva.

■ *Tumor de células granulosas* [4, 47]

Antiguamente denominado tumor de Abrikossoff o mioblastoma de células granulosas, este tumor correspondería a una proliferación de las células de Schwann.

Estos tumores pueden aparecer en todas las edades y en todos los órganos, pero con mayor preponderancia las localizaciones son orofaríngeas y bucales.

Clínicamente, esta lesión aparece como un nódulo submucoso que puede alcanzar varios centímetros, y a veces una coloración amarillenta. Este tumor puede ser multifocal.

Es una lesión no encapsulada que presenta un potencial evolutivo lento, pero se ha descrito la posibilidad de malignización. El tratamiento estriba en una exéresis quirúrgica amplia con estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica. Cabe mencionar que esta lesión presenta una radiosensibilidad muy baja.

TUMORES DE ORIGEN MUSCULAR

Rabdomioma [3, 47]

Los rabdomiomas son tumores benignos desarrollados a expensas del tejido muscular estriado. A nivel faríngeo los rabdomiomas extracardíacos son poco frecuentes y si aparecen suelen hacerlo en la orofaringe. Las localizaciones múltiples son excepcionales.

Estos tumores se desarrollan habitualmente en el adulto adoptando el aspecto clínico de una tumefacción submucosa, sin carácter específico.

Histológicamente, se describen un tipo fetal y un tipo adulto según la maduración de las fibras musculares esqueléticas que lo componen. Sin embargo, el diagnóstico diferencial con el rabdomiosarcoma puede ser difícil de establecer. El tratamiento consiste en la exéresis quirúrgica, con estudio anatomopatológico de la pieza.

Las recidivas se atribuyen a la persistencia de un resto tumoral.

Leiomiomas [18, 32]

Son tumores benignos, desarrollados a expensas de células musculares lisas. A nivel de la faringe, las lesiones aparecen a partir de células musculares lisas de los vasos o a partir de células mesenquimatosas indiferenciadas. A nivel de la faringe, estas lesiones son poco frecuentes y si aparecen lo hacen en la orofaringe. Clínicamente, se trata de pequeños nódulos submucosos, únicos o múltiples. Histológicamente, el diagnóstico es difícil y debe hacerse un estudio con microscopio electrónico. Existen formas de transición con los leiomiosarcomas, lo que justifica una exéresis quirúrgica completa.

OSTEOCONDROMAS [11, 48]

Son lesiones constituidas por tejido óseo (osteomas), cartilaginoso (condromas) o, a menudo, de tejido mixto (osteocondromas). Estas lesiones, que se localizan de preferencia en la base de la lengua o en la pared faríngea posterior, son más habituales en la mujer, entre los 20 y 40 años. Clínicamente, se observa una forma pediculada a menudo infracentimétrica, responsable de disfagia. Histológicamente, esta lesión está constituida por tejidos óseos o cartilaginosos maduros o por una mezcla de ellos. El tratamiento es quirúrgico, por exéresis endoscópica de la lesión.

PAPILOMAS Y LESIONES ASOCIADAS [8, 31]

Los papilomas son proliferaciones epiteliales, digitiformes, cuyo origen es controvertido entre factores traumáticos y virales. Estas lesiones, únicas o múltiples, aparecen con mayor frecuencia en la orofaringe y afectan al adulto. El tratamiento es la exéresis quirúrgica. Las recidivas son escasas. Esta lesión debe diferenciarse de la papilomatosis laríngea juvenil que, en las formas floridas, puede presentar una extensión faríngea. En este caso, el pronóstico y el tratamiento dependen de la extensión laríngea. Se debe diferenciar de los condilomas acuminados, cuyo aspecto clínico puede ser similar. Estas lesiones están causadas por el Papilomavirus (hPV *[human Papillomavirus]*). Se trata de lesiones venéreas que se pueden encontrar tanto en la orofaringe como en cualquier parte del tracto aerodigestivo.

El diagnóstico anatomopatológico revela una proliferación epitelial, digitiforme, pediculada o sésil, sin queratinización. El tratamiento consiste en la exéresis o la electrocoagulación de la lesión.

LIPOMAS [5, 20, 24]

Los lipomas son tumores desarrollados a partir de células adiposas.

La localización faríngea es inusual. Afectan principalmente al adulto, sin preponderancia de sexo. Clínicamente, los lipomas se presentan en forma de un tumor sésil, submucoso, de aspecto amarillento si son superficiales, siendo generalmente asintomáticos. Se han dado casos, poco habituales, de localizaciones múltiples. Bien que, en la literatura se ha descrito la posibilidad de malignización a liposarcoma, esta evolución parece excepcional. El tratamiento es la exéresis quirúrgica. Estas lesiones no recidivan.

PLASMOCITOMAS EXTRAMEDULARES [41, 45]

Los plasmocitomas corresponden a la proliferación de un clon plasmocitario, por lo general de localización ósea. Las localizaciones faríngeas aparecen sobre todo en la rinofaringe, excepcionalmente en la orofaringe. Clínicamente, estas lesiones se presentan como tumefacciones, pediculadas o difusas, que suelen tener una coloración roja. Por lo general son de localización única.

El estudio clínico y radiológico debe descartar otras localizaciones.

El tratamiento de elección sigue siendo la exéresis quirúrgica. Se puede recurrir a la radioterapia en las formas extensas, que exigirían una cirugía mutilante.

HIPERTROFIA LINFOIDE [19, 25]

Se trata de una proliferación de elementos linfoides frecuentemente observada a nivel de la rinofaringe, de la base de la lengua y de la pared faríngea posterior.

Estos nódulos linfoides, únicos o múltiples, pueden alcanzar el tamaño de 1 cm.

El color suele ser amarillo o gris. Con frecuencia las lesiones son asintomáticas, salvo en caso de factor irritativo, y generalmente no son tributarias de ningún tratamiento. Sin embargo, hay que mencionar que se han descrito transformaciones malignas en pacientes que padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Sida), lo que impone un control clínico y radiológico de estas lesiones.

TUMOR AMILOIDE

Los tumores amiloides son un depósito de sustancia amiloide en la matriz extracelular.

Se trata de lesiones submucosas de evolución lenta. Los tumores amiloides se han descrito en la orofaringe y sobre el borde de la laringe. La exploración debe descartar otras posibles localizaciones de la amilasa. El tratamiento de las localizaciones faríngeas es quirúrgico, con el objeto de evitar las recidivas.

FIBROMA NASOFARÍNGEO

Esta lesión se describe en el fascículo 20-405-A-10 de la misma colección, por lo que aquí sólo se menciona.

Diagnóstico diferencial

El diagnóstico diferencial trata de eliminar una compresión extrínseca. En primer lugar están los tumores de los espacios parafaríngeos y retrofaríngeos, que se presentan bajo la forma de una tumefacción submucosa disminuyendo la luz de la orofaringe. Los tumores retrofaríngeos son sobre todo adenopatías o, con menor frecuencia, cordomas. Más frecuentes, los tumores parafaríngeos preestiloideos suelen ser de origen parotídeo y se desarrollan a expensas de la parte profunda de la glándula. Por último, los tumores parafaríngeos retroestiloideos están representados por los quemodectomas y los

tumores nerviosos. El diagnóstico, a menudo sospechado clínicamente, se confirma por escáner y/o RM. La vía de acceso de estos tumores es la de parotidectomía asociada o no a un acceso transoral, o por vía transmandibular.

También cabe mencionar la extensión a la rinofaringe de un tumor desarrollado desde las estructuras adyacentes tales como los senos y las fosas nasales (pólipo esfenocoanal) o los meningoceles y meningoencefaloceles. Antes de efectuar cualquier biopsia de una tumefacción de la rinofaringe debe descartarse el diagnóstico de meningocele y meningoencefalocele. La radiología permite orientar el diagnóstico.

Por último, hay que descartar las lesiones inflamatorias agudas o crónicas que pueden adoptar un aspecto pseudotumoral, como la tuberculosis, la sarcoidosis, las granulomatosis y las sifílides. El diagnóstico diferencial se basa principalmente en la radiología y, si es preciso, en el estudio histológico.

Conclusión

Los tumores benignos de la faringe abarcan un conjunto de etiologías muy variadas.

Entre ellas, algunas presentan un riesgo de transformación maligna o un potencial evolutivo que conviene dignosticar y tratar precozmente.

Por otra parte, algunos tumores precisan actitudes terapéuticas específicas, lo que justifica un diagnóstico etiológico preciso.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Fayoux P, Chevalier D et Dubrulle F. Tumeurs bénignes du pharynx. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-586-A-10, 1998, 6 p.

Bibliografía

[1] Al Samarrae SM, Amr SS, Hyams VJ. Polypoid lymphangioma of the tonsilla: report of two cases and review of the literature. *J Laryngol Otol* 1985 ; 99 : 819-823

[2] Basma NJ, Robin PE. Hemimacroglossis associated with plexiform neurofibromatosis. A case report. *J Laryngol Otol* 1987 ; 101 : 743-745

[3] Batsakis JG. Tumors of the head and neck. Baltimore : Williams and Wilkins, 1979

[4] Bedbeder P, Gehanno P. Localisations ORL des tumeurs d'Abrikossoff. À propos de huit observations. Une tumeur qui n'est pas toujours anodine. *Ann Otolaryngol (Paris)* 1985 ; 102 : 169-173

[5] Bennhoff DF, Wood JW. Infiltrating lipomata of the head and neck. *Laryngoscope* 1978 ; 88 : 83

[6] Bessede JP, Chassagnac F, Guibbac JL, Huty J, Sauvage JP. Le point sur le traitement chirurgical des kystes du tractus thyréoglosse. *J Fr Otorhinolaryngol* 1991 ; 40 : 3-6

[7] Braun IF, Levy S, Hoffman JC. The use of transarterial microembolization in the management of hemangiomas of the perioral region. *J Oral Maxillofac Surg* 1985 ; 43 : 239

[8] Brodsky L, Siddioui SY, Stanievich JF. Massive oropharyngeal papillomatosis causing obstructive sleep apnea in a child. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 1987 ; 113 : 882-884

[9] Byard RW, Qmith CR, Chan MS. Endodermal sinus tumor of the nasopharynx and previous mature congenital teratoma. *Pediatr Pathol* 1991 ; 11 : 297-302

[10] Casino AJ, Sciubba JJ, Chri GL, Rosner F, Winston J, Yuuis M et al. Oral facial manifestations of the multiple endocrine neoplasia syndrome. *Oral Surg* 1981 ; 51 : 516-523

[11] Charneux F, Bretagne MC, Hoeffel JC. Tumeur rare du pharynx. L'ostéochondrome extra-osseux. *J Radiol* 1981 ; 62 : 335-337

[12] Cook KL, Dipietro MA, Bodgasarian RS. An elusive nasopharyngeal hamartoma in a neonate. *Pediatr Radiol* 1988 ; 18 : 351-352

[13] De-Vries EJ, Sekhar LN, Jones JF, Schramm VL, Hirsch BE. Nasopharyngeal teratoma involving the temporal bone. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1988 ; 16 : 167-173

[14] Francois M, Le Guillou C, Depondt J, Aboucaya JP, Contencin PH, Narcy PH. Les lymphangiomes cervicofaciaux chez l'enfant. *Ann Otolaryngol (Paris)* 1986 ; 103 : 113-117

[15] Garabedian EN, Leperchey F. Embryogénie des kystes et fistules congénitales du cou. Actualité d'une question ancienne. *Cah ORL* 1995 ; XXX : 189-198

[16] Goldberg MH, Nemarich AN, Danielson P. Lymphangioma of the tongue: medical and surgical therapy. *J Oral Surg* 1977 ; 35 : 841

[17] Gooder P. Follicular carcinoma in a lingual thyroid. *J Otolaryngol* 1980 ; 94 : 472

[18] Greenberg E, Shupak A, Kelner J, Heyer WS. Tonsillar leiomyome. *J Laryngol Otol* 1987 ; 101 : 619-623

[19] Gromet E, Homer HK, Cartel BL. Lymphoid hyperplasis at the base of langue: the Tongue-Spectrum of a benign entity. *Radiology* 1982 ; 144 : 825-828

[20] Grybauskas VT, Shugar MA. Nasopharyngeal Lipoma. *Laryngoscope* 1983 ; 93 : 362-363

[21] Haguenauer JP, Pignat JC, Gaillard J, Navailles F. Les ectopies thyroïdiennes linguales chez l'adulte (à propos de cinq observations). *J Fr Otorhinolaryngol* 1987 ; 37 : 99-103

[22] Harel G. Congenital pleomorphic adenoma of the nasopharynx (report of a case). *J Laryngol Otol* 1985 ; 99 : 1281-1287

[23] Heilfmer DJ. Teratoid and neural tumors of the nose, rhinonasal tract and nasopharynx. *Int J Pediatr Otorhinolaryngol* 1983 ; 6 : 1-21

[24] Jesberg N. Fibrolipoma of the pyriform sinuses: thirty-seven years follow-up. *Laryngoscope* 1982 ; 92 : 1157-1159

[25] Kieserman SP, Stern J. Malignant transformation of nasopharyngeal lymphoid hyperplasia. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1995 ; 113 : 474-476

[26] Leroux-Robert J. Les tumeurs nerveuses ORL et cervicofaciales. Actualités de carcinologie cervicofaciale. Paris : Masson, 1976 : 1-216

[27] Maceri DR, Saxton KG. Neurofibromatosis of the head and neck. *Head Neck Surg* 1984 ; 6 : 842

[28] Meyer B, Chabolle F, Marsot-Dupuch K, Riu B. Kystes de la bourse de Tornwaldt. À propos de trois cas. *Ann Otolaryngol (Paris)* 1988 ; 105 : 183-187

[29] Michal M, Sokol L, Mukensnabl P. Salivary gland anlage tumor. A case with widespread necrosis and large cyst formation. *Pathology* 1996 ; 28 : 128-130

[30] Mulliken JB, Glowacki J. Hemangiomas and vascular malformations in infants and children : a classification based on endothelial characteristics. *Plast Reconst Surg* 1982 ; 69 : 412-420

[31] Nash M, Lucente FE, Srinivasan K, Gould WJ. Condylomatous lesions of the upper aerodigestive tract. *Laryngoscope* 1987 ; 97 : 1410-1416

[32] Nathilla JR, Neiders ME, Greene GW. Oral leiomyomas : report of six cases and a review of literature. *J Oral Pathol* 1985 ; 11 : 353

[33] Nicklaus PJ, Forte V, Thorner PS. Hairy polyp of the eustachian tube. *J Otolaryngol* 1991 ; 20 : 254-257

[34] Nicolai P, Luzzago F, Maroldi R et al. Nasopharyngeal Cysts. Report of seven cases with review of the literature. *Arch Otolaryngol* 1989 ; 115 : 860-864

[35] Ophir D, Lifschitz-Mercer B. Oncocytic cystic lesions of the upper respiratory tract. *Ear Nose Throat J* 1989 ; 68 : 237-238, 240 : 243-244

[36] Papay FA, Kalucis C, Eliachar I, Tucker HM. Nasopharyngeal presentation of second branchial cleft cyst. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1994 ; 110 : 232-234

[37] Patterson C, Dickerson GR, Pilch BZ, Bentkover SH. Hamartoma of the hypopharynx. *Arch Otolaryngol* 1981 ; 107 : 767-772

[38] Pech A, Leroux-Robert J. Les chémodectomes cervicocéphaliques (paragangliomes). Actualités de carcinologie cervicofaciale. Paris : Masson, 1984 ; 10 : 1-192

[39] Perzin KH, Panyu H, Wechter S. Non epithelial tumors of the nasal cavity, paranasal sinuses and nasopharynx. A clinicopathologie study. XII: Schwann cell tumors (neurilemmoma, neurofibroma, malignant schwannoma). *Cancer* 1982 ; 50 : 2193-2202

[40] Remacle H, Dejonckere PH. Un cas de tératome rhinopharyngé chez l'adulte. *Acta Otorhinolaryngol Belg* 1980 ; 34 : 568-573

[41] Sadek SA, Dogra TS, Khan MK, Baraka ME, Sidhom NN. Plasmocytoma of the nasopharynx (a case report with a follow-up of twelve years). *J Laryngol Otol* 1985 ; 99 : 1289-1292

[42] Schartz HE, Ward PH. Aggressive fibromatosis of the tongue. *Ann Otol* 1978 ; 88 : 12-15

[43] Shidara K, Uruma T, Yasuoka Y, Kamoi T. Two cases of nasopharyngeal branchial cyst. *J Laryngol Otol* 1993 ; 107 : 453-455

[44] Tamagawa Y, Kitamura K, Miyata M. Branchial cyst of the nasopharynx: resection via the endonasal approach. *J Laryngol Otol* 1995 ; 109 : 139-141

[45] Trassera J, Cardesa A, Roura J, Avellaneda R, Condom E, Campos E. Plasmocytome solitaire des voies aérodigestives supérieures. Présentation de trois observations. *Ann Otolaryngol (Paris)* 1988 ; 105 : 103-107

[46] Triaridis C, Tsalighopoulos PG, Kooloulas A, Var-Tholomeos A. Posterior pharyngeal wall schwannoma (case report). *J Laryngol Otol* 1987 ; 101 : 749-752

[47] Van Der Waal I, Gordon B. Benign tumors and tumorlike lesions of oral cavity and oropharynx. St Louis : Mosby Year Book, 1993 : 1237-1247

[48] Van Der Waal N, Van Der Waal I. Osteoma or chondroma of the tongue; a clinical and postmortem study. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1987 ; 16 : 713

[49] Van Der Waal N, Wiener JO, Van, Der Waal I. Lingual thyroïd; a clinical and postmortem study. *Int J Oral Maxillofac Surg* 1986 ; 15 : 431

[50] Yanagisawa E, Yanasisawa K. Endoscopic view of Thornwaldt cyst of the nasopharynx. *Ear Nose Throat J* 1994 ; 73 : 884-885

[51] Zarbo RJ, Mc Clatchey KD. Nasopharyngeal hamartome: report of a case and review of the literature. *Laryngoscope* 1983 ; 93 : 494-497

[52] Zerella JP, Finberg FJ. Obstruction of the neonatal airway from teratomas. *Surg Gynecol Obstet* 1990 ; 170 : 126-131